Tratamiento psicológico del dolor oncológico

Dolor crónico: dolor oncológico

tech

CONTENIDO

1. Objetivo
2. Introducción
3. Psicoterapia
4. Terapia cognitiva
5. La Terapia Cognitivo Conductual (TCC)
   Afrontamiento psicológico
6. Intervención psicosocial y psicoeducativa
   Psicoterapia de grupo
7. Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)
8. Técnicas de relajación
9. Conclusiones
10. Bibliografía

Objetivo

Conocer el tratamiento psicológico del dolor oncológico.

Introducción

Ser diagnosticado de cáncer es una de las situaciones más estresantes y temida en la actualidad. Perder la vida es el pensamiento más inmediato que viene a la conciencia del enfermo en cuanto el médico le informa del diagnóstico. En la enfermedad oncológica se dan una serie de circunstancias que producen un fuerte malestar psicológico como: su cronicidad, la incertidumbre ante la evolución, la alteración de la rutina diaria, problemas de adaptación, dificultades familiares y sociales (1).

El paciente con cáncer sufre de muchas pérdidas (1):

- Pérdida de identidad, aunque sea momentáneamente, la persona deja de sentirse y valorarse a sí mismo como lo hacía antes de padecer la enfermedad (1).
- Pérdida de control, cuando se aplican los tratamientos oncológicos, el enfermo puede sentir que su vida escapa de su control, puesto que para su recuperación se tiene que poner en manos de otros (1).
- Pérdida de relaciones, no sólo las personas que puedan alejarse a causa de la enfermedad, sino las que acompañan al enfermo en el proceso, muchas veces pueden no ser conscientes del estado de malestar que sufre el enfermo, para así paliar su propia preocupación (1).

Algunas veces, las personas que acompañan al enfermo, intentan ser optimistas todo el tiempo, no dejando que el paciente comparta los estados emocionales negativos, esto puede generar que el enfermo se aísle emocional y socialmente (1).

Ejemplo de este tipo de actuación es la siguiente declaración:

> *"Mi madre no tolera mis momentos de debilidad, no soporta que llore, verme triste. Me dice: si tú lloras, yo lloro, si tú sufres, yo sufro… y se queda tan ancha. Así no me ayuda nada" (1).*

Pérdida de la sexualidad, para algunos adultos, la vida sexual tras los tratamientos oncológicos recibidos no vuelve a ser la misma. Muchos reciben tratamientos hormonales que pueden hacer que su vida sexual no sea placentera, lo que puede afectar a la autoestima (1).

Además, se puede experimentar el miedo por no poder tener hijos, lo que puede llevar a la necesidad de un cambio de prioridades en la vida, y a una reorganización cognitiva y emocional. Las pacientes que suelen ver más afectadas su sexualidad son las que han sufrido un cáncer de mama (sobre todo si les han realizado una mastectomía). Un ejemplo de esta experiencia sería el siguiente:

> *"Me veo hecha polvo, me pesa la prótesis, me siento media mujer, a raíz de la mastectomía no he tenido relaciones sexuales por falta de deseo, no me siento mujer…" (1).*

Pérdida de la autoimagen, el papel de los que están alrededor del enfermo, es primordial para que éste se adapte a las nuevas circunstancias. Acompañar al enfermo, requiere mostrar empatía ante el estado emocional que éste muestre, así se sentirá entendido. La imagen corporal se ve muy afectada, en la mayoría de los casos por la alopecia como efecto secundario de la quimioterapia, pero sobre todo en las mujeres si al sufrir cáncer de mama ha sido necesario hacer una mastectomía (1).

Es frecuente escuchar entonces algunos de estos testimonios:

> *Ya no me siento mujer" "A mí me influyo que en la primera sesión (de quimioterapia) me tengo que cortar el pelo, porque en seguida se me empezó a caer (…) me puse gorritos, nunca me puse peluca porque no me gustaba. Llevé mal lo del pelo, y en lugar de llorar porque tenía una enfermedad muy mala, que me podía morir, lloraba por mi aspecto físico…" (1).*

Pérdida del estilo de vida: la interrupción transitoria de la rutina, causa malestar en los pacientes, pero en mayor medida en pacientes con un escaso apoyo social o que tienen a otras personas a su cargo. Además, surgirá el miedo por no poder retomar la vida diaria en un futuro (1).

Pérdida del proyecto de futuro, puede estar referido al miedo a no poder emprender o retomar la carrera profesional, no poder hacer frente a distintas demandas económicas o consolidar planes de futuro con otras personas. Esta pérdida ésta caracterizada por la incertidumbre que trae consigo el diagnóstico del cáncer (1).

Pérdida del esquema de los valores esenciales, pueden surgir demandas relacionadas con los cambios impuestos por la enfermedad, por las consecuencias familiares y sociales que ésta pueda tener, o por el sentido de la enfermedad y una necesidad de realizar un gran cambio en sus vidas. El cáncer puede transformar las prioridades que las personas tenían previamente, y entre ellas, su esquema de valores (1).

No es raro que la persona con cáncer esté más lábil emocionalmente, lo que se traduce en ansiedad, indefensión y desesperanza. Otras veces, el paciente puede experimentar emociones como la ira o la rabia, además de la sensación de encontrarse solo/a en el proceso (1).

Se trata generalmente de personas con una calidad de vida disminuida, que se enfrenta a múltiples temores. La forma en la que la persona se enfrenta a la enfermedad dependerá de (1):

- La conciencia que tenga de la misma.
- Su historia personal.
- Los recursos de afrontamiento que tenga disponibles para tal situación.

Los pacientes con cáncer son personas sometidas al miedo, y pueden mostrarse irascibles ante la percepción de la pérdida de la salud, y de control en sus vidas. Por otro lado, el impacto de la enfermedad no sólo afecta al paciente, sino también a su familia, por la incertidumbre y procesos que conlleva el diagnóstico y el tratamiento (1).

El cáncer puede tener una gran afectación en las relaciones sociales, pudiendo debilitar la red de apoyo social, los pacientes cuando reciben el diagnóstico pueden sentirse incomprendidos, sentir que nadie entiende sus pérdidas (físicas, emocionales, sociales, laborales, etc.) y aislarse (1).

Dadas las necesidades psicológicas de los pacientes con cáncer y sus familiares, surge la Psicooncología, definida según Alonso y Sebastián como 'disciplina que estudia la relación entre los procesos psicológicos y la patología neoplásica, así como la utilidad de las intervenciones psicológicas para tratar la problemática asociada al diagnóstico y al tratamiento de esta enfermedad' (1).

El objetivo final del psicooncólogo/a ha de ser la mejora del bienestar físico y emocional del paciente, su familia, y su entorno. Su foco de interés va a ir dirigido a estudiar las distintas estrategias de afrontamiento y acciones terapéuticas más útiles para mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer, en cualquiera de los estadios en los que se encuentren (1).

La mayoría de las aproximaciones terapéuticas al tratamiento psicológico de pacientes con cáncer se han basado en intervenciones psicosociales o cognitivo-conductuales (2).

En ellas, en especial desde estas últimas, se establece como objetivo del tratamiento el cambio o control de los pensamientos y emociones aversivos, cuya función se conceptualiza como causal respecto al comportamiento problemático que presenta el paciente. Por tanto, esta perspectiva asumiría como premisa la eliminación de los eventos privados negativos como requisito indispensable de la salud psicológica y, por ende, del tratamiento (2).

Las terapias cognitivo - conductuales han demostrado ser particularmente eficaces en aquellos pacientes que utilizan un estilo de afrontamiento pasivo / evitativo o de negación. Sin embargo, también presentan algunas limitaciones, como no haber proporcionado hasta la fecha ningún dato o evidencia del mecanismo de acción por el que resultan eficaces (2).

Es decir, aun demostrando ser eficaces, todavía no se conoce si su eficacia obedece a los componentes cognitivos, conductuales o a una conjunción de ambos. Además, se ha podido comprobar que, tras finalizar la intervención, la mejoría en la sintomatología psicológica de los pacientes con cáncer se atenúa con el paso del tiempo (2).

En contraste, en los últimos años ha surgido un elenco de nuevas terapias psicológicas, popularizadas como "contextuales" o de "tercera generación", que siguen una perspectiva funcional y contextual para explicar de forma empírica la relación de la cognición y el lenguaje con los patrones de comportamiento observables (2).

De todas ellas, quizás pueda considerarse la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) como paradigmática, al ser la más completa, mejor desarrollada y que cuenta con un fundamento teórico más sólido, sustanciado en la Teoría del Marco Relacional (RFT), como explicación del lenguaje y de la cognición humana desde los principios del análisis funcional de la conducta (2).

Para la ACT, la naturaleza verbal del ser humano impide la posibilidad de evitar completamente la irrupción de cogniciones (del pasado, presente o futuro, tales como los recuerdos, valoraciones o anticipaciones), así como de que aparezcan cargadas de emociones de distinta valencia afectiva. Por consiguiente, dado que la agenda establecida culturalmente apunta a la necesidad de "sentirse bien" como criterio de normalidad psicológica, la persona se funde en un sinfín de acciones que intentan acabar con los pensamientos y emociones etiquetados socialmente como negativos (2).

Este proceso, denominado evitación experiencial o inflexibilidad psicológica, consistiría en un patrón de conducta generalizado cuya función es evitar el contacto con una experiencia privada aversiva concreta e intentar controlar su forma o la frecuencia de aparición. Aunque este comportamiento genera un alivio inmediato, a largo plazo resulta contraproducente, improductivo y limitante en la actuación de la persona en la consecución de lo que es importante en su vida (2).

Por lo tanto, la ACT estaría indicada para el tratamiento de todos aquellos problemas psicológicos caracterizados por un patrón de evitación experiencial cronificado y limitante, como puedan ser los trastornos afectivos, trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos por consumo de sustancias, trastornos psicóticos, dolor crónico, o trastornos adaptativos secundarios a una enfermedad médica, como el cáncer (2).

En el caso del cáncer, desde el momento en que un paciente recibe el diagnóstico, pasa por innumerables situaciones nuevas, llenas de incertidumbre, que suponen una alta carga estresante por las preocupaciones, temores y el dolor asociados; al igual que la presencia de síntomas depresivos. En este sentido, cabe destacar también, tal y como se recoge en el metaanálisis de Mitchell *et al.*, que el 12,9-29,8 % de los pacientes con cáncer sufren depresión, y entre el 5,1-17 % experimentan ansiedad (2).

Tanto la ansiedad como la depresión pueden influir de manera independiente en la salud de los pacientes oncológicos, constituyendo, por tanto, un reto actual la gestión eficaz de estos síntomas. A esto hay que añadir que, en no pocas ocasiones, los pacientes pierden el contacto con amigos y familiares por miedo a la reacción que estos puedan tener (2).

Por otra parte, el proceso de tratamiento médico del cáncer es complejo y habitualmente se asocia con complicaciones que influyen a nivel físico, psicológico y social, tanto en los pacientes como en sus familiares, que tienen que proporcionar cuidado y apoyo emocional al enfermo, obligándoles a asumir nuevas responsabilidades (2).

Para los hijos de padres diagnosticados de cáncer, la enfermedad se convierte en un estresor de primera magnitud y de características únicas, que llega a comprometer seriamente su bienestar emocional. Así, por ejemplo, pueden adolecer de no tener cubiertas muchas de sus necesidades, como el soporte emocional familiar, puesto que toda la atención del entorno se centra en el enfermo; o también pueden sufrir la falta de comprensión de la enfermedad que sufre alguno de sus progenitores, entre otros problemas (2).

Tal y como mencionan en su estudio de revisión Visser *et al.,* los niños en edad escolar, cuyo progenitor está enfermo de cáncer, presentan más miedo a la enfermedad y al tratamiento. En el caso de los adolescentes, pueden mostrar tanto problemas externalizantes (problemas académicos, dificultades para dormir, dolores de estómago) como internalizantes (síntomas depresivos y ansiosos) (2).

Se ha observado, además, que el diagnóstico de cáncer en un miembro de la pareja también provoca un desajuste psicológico en el otro miembro. De hecho, en muchas ocasiones los roles de la pareja cambian para poder cubrir todas las necesidades de los pacientes con cáncer, sacrificando sus actividades habituales y sus aficiones (2).

En cuanto a la intervención, han sido muchos los estudios realizados con el fin de demostrar la eficacia de los diferentes tratamientos psicológicos en el cáncer. Así, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual ha evidenciado su efectividad en los síntomas psicopatológicos que suelen presentar los pacientes, incluyendo para ello, en la mayoría de sus programas, técnicas para el control del estrés y la resolución de conflictos (2).

Sin embargo, todas estas estrategias vuelven a hacer hincapié en el control y reducción de los síntomas, tales como temores, penas y padecimientos, para así sentirse mejor y eliminar la amenaza asociada al cáncer. Por el contrario, conseguir distanciarse de los propios pensamientos (defusión cognitiva), evitando el control emocional y cognitivo, ha resultado ser mucho más eficaz en el tratamiento de los síntomas psicológicos en los enfermos de cáncer que el protocolo TAU3, de orientación cognitivo-conductual, que incluye técnicas de relajación, resolución de problemas y reestructuración cognitiva (2).

En esta misma dirección, Páez *et al*. concluyen que la ACT es más efectiva que los tratamientos cognitivo-conductuales, especialmente a largo plazo, y en la implicación de los pacientes hacia sus acciones valiosas (2).

Pese a ello, existen comparativamente muy pocas las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre la aplicación de la ACT en pacientes con cáncer, como también dirigidas a estudiar el papel de la aceptación de las alteraciones emocionales en estos pacientes, con el fin de que les ayude a manejarlos y a actuar según sus valores (2).

Para el tratamiento psicológico adecuado del dolor oncológico es necesaria una apropiada valoración multimodal del dolor, por lo que se debe tener en cuenta, al menos, seis dimensiones (3):

1. Fisiológica (localización, duración, etiología y tipo de dolor visceral, somático o neuropático).
2. Sensorial (intensidad, cualidad y patrón doloroso).
3. Afectiva (influencia sobre el estado de ánimo, sensación de bienestar y nivel de ansiedad o depresión).
4. Cognitiva (significado del dolor para el paciente, relación con la neoplasia, estrategias de afrontamiento).
5. Conductual (impacto del dolor sobre el comportamiento y la conducta: actividad física, sueño, etc.).
6. Socio - cultural (factores étnicos, familiares, laborales, sociales y espirituales) (3).

Psicoterapia

Hay tres tipos de aproximaciones psicoterapéuticas (4):

1. Abordaje cognitivo - conductual. Va dirigido al manejo o control de la ansiedad y la sintomatología depresiva asociada al dolor (4, 5).
2. Terapia de soporte. De corta duración (cuatro a seis semanas), y dirigidas a la clarificación, validación y resolución de problemas del paciente relacionados con su enfermedad, a los objetivos y expectativas de los tratamientos y los miedos acerca del morir o del sufrimiento y la muerte (4).
3. Psicoterapias centradas en el sentido. Promueven o mantienen conceptos terapéuticos como sentido, compasión o dignidad, que disminuyen el sufrimiento emocional o lo que se ha llamado anteriormente “clínica del desespero” que, de manera directa o indirecta, ayudan a mejorar el control del dolor (4).

Terapia cognitiva

Son un conjunto de técnicas dirigidas a afrontar o manejar los pensamientos y emociones asociados al dolor (6). Principalmente se emplea la técnica denominada "reestructuración cognitiva", con la cual se intenta que el paciente cambie los pensamientos y emociones que anticipan o aumentan la sensación de dolor (4).

Por ejemplo, pensar que por la noche aumenta el dolor y lo que ocurre en realidad es que el paciente no se encuentra acompañado durante el ingreso o que piensa que la enfermera o el médico no llegará a tiempo para poder controlar una crisis de dolor. Esta técnica permite, por ello, trabajar con "escenarios futuros" asociados a dolor que teme el paciente (4).

La Terapia Cognitivo Conductual (TCC)

Se corresponde con una intervención en salud que abarca respuestas físicas, emocionales, cognitivas y conductuales desadaptadas, de carácter aprendido. Estas respuestas se han repetido de tal manera a lo largo del tiempo que el individuo las ha convertido en hábitos. La TCC considera que el paciente puede ejercer control sobre ellos y, por lo tanto, modificarlos (5).

La aplicación de esta terapia cuenta con un tiempo limitado al buscar una mejora a corto y medio plazo. Se ha convertido en la orientación psicoterapéutica con mayor evidencia empírica y experimental respecto a su eficacia y efectividad en relación con un amplio número de trastornos psicológicos. Potencia las habilidades del paciente de manera que favorece su adaptación al entorno y una mejora de la calidad de vida (5).

Un estudio llevado a cabo mediante Redes semánticas naturales modificadas y propuestas por Reyes y Lagunes en 2011 y puesto en práctica por Ana Leticia Becerra Gálvez *et al*. se basa en la intervención psicológica para el control de pensamientos intrusivos, ansiedad y depresión demuestra que, la TCC supone una fuente de reforzamiento natural la cual favorece la mejora del estado de ánimo, evitando la presencia prolongada en el tiempo de ansiedad y depresión incluso fuera del ámbito hospitalario. Se realizaron de 6 a 10 sesiones de forma individual. Se obtuvieron resultados estadísticamente significativos (5).

Otro estudio preexperimental, cuantitativo, con un grupo de muestreo por conveniencia, realizado por Ana Lucía González García *et al*. se demuestra la eficacia de la TCC además de en la disminución de los niveles de ansiedad y depresión, en el desarrollo de habilidades de afrontamiento positivo en cuanto a la mejora de la percepción de la calidad de vida. En este caso la terapia fue individual con una media de 10 sesiones. Se obtuvieron resultados estadísticamente significativos (5).

Afrontamiento psicológico

Según Lazarus y Folkman (1), el afrontamiento se define como

> *Aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo".*

Siguiendo a Watson y Greer, en el caso del cáncer, el afrontamiento se refiere a las respuestas cognitivas y conductuales de los pacientes ante el cáncer, comprendiendo el significado que tiene el cáncer para la persona, y las reacciones psicológicas que tienen lugar, lo que el enfermo piensa y hace para reducir la amenaza que implica el proceso oncológico (1).

En este contexto, Moorey y Greer plantearon un modelo de acción ante el cáncer, denominado "esquema de supervivencia" que incluye la capacidad de adaptación, respuesta emocional, y los distintos estilos de afrontamiento que la persona pone en marcha ante el diagnóstico de la enfermedad. En este esquema se considera la visión del diagnóstico que tiene el paciente, el tipo de control que cree que puede tener sobre la enfermedad, y también, la opinión del pronóstico que tiene el enfermo (1).

Existen dos tipos de respuestas de afrontamiento (1):

Pasivas, se produce un mal ajuste, aquí se encontrarían las estrategias de fatalismo, preocupación ansiosa, y desesperanza (1).

Activas, muestran una mejor adaptación a la enfermedad, y estarán formadas por las estrategias de espíritu de lucha y evitación / negación (1).

Según Heim y cols (1).

> *Parecen existir evidencias a favor a la hora de considerar que al inicio de la enfermedad se suelen emplear más estrategias de afrontamiento que al final de las mismas, siendo distintas el tipo de estrategias que se emplean en las diferentes fases".*

En cualquier caso, cuando el/la paciente se enfrenta al cáncer, las áreas afectivas, conductuales, y cognitivas, se pueden alterar, dando lugar a un mal control por parte del paciente de su enfermedad, pudiendo darse el abandono del tratamiento, mayor percepción de dolor, trastornos psicológicos asociados, etc. Es decir, si no hay un buen afrontamiento del diagnóstico, se puede predecir que el desempeño en la vida diaria, y los posibles tratamientos oncológicos, se verán muy afectados (1).

Intervención psicosocial y psicoeducativa

La atención psicosocial de las personas con enfermedad oncológica y la familia debe formar parte de todo modelo integral de atención que pretenda reducir el impacto vital del cáncer. Las intervenciones psicosociales han probado su eficacia en la ayuda a pacientes y familiares para afrontar las situaciones de alta complejidad psicosocial emergentes a consecuencia de un diagnóstico de cáncer (7).

Implantar al inicio del tratamiento intervenciones psicosociales que faciliten la adaptación del paciente y la familia, y establecer intervenciones psicoeducativas y cognitivo-conductuales como parte del plan general de cuidados para el manejo del dolor, evitando creencias erróneas pueden ser de gran utilidad. Nivel de Evidencias III (6, 8).

La intervención psicológica en el paciente con dolor tiene las siguientes finalidades (8):

- Aliviar y cuando se pueda, eliminar el dolor.
- Aumentar los niveles de bienestar físico y psíquico de los pacientes.
- Restablecer las funciones y actividades necesarias para que el individuo recupere su autonomía.
- Motivar al paciente para que realice cambios o modificaciones de hábitos, actitudes y conductas inadaptativas.
- Prevenir complicaciones a posteriori, como los bucles ansiedad - dolor depresión o la cronificación del dolor.

El apoyo social dota a las personas de una red de ayuda, oportunidades y cuidados que también influyen sobre el dolor y su control. Las consecuencias positivas del apoyo social (permitir la descarga emocional, generar sentimientos positivos, proporcionar información sobre procedimientos y acontecimientos, facilitar oportunidades) contribuyen indirectamente a mejorar los niveles de dolor y a disminuir la intensidad de los cuadros depresivos asociados a ese dolor (8).

El personal sanitario debe reforzar comportamientos adaptativos y hacer intervenciones educativas, esto ayuda a aliviar el estrés, el dolor y a mejorar el bienestar del paciente. Estas intervenciones son (8):

- Facilitar información sobre la asistencia sanitaria (nivel de Evidencia Ib), ayudar al aprendizaje de habilidades (respiración, relajación, distracción) (nivel de evidencia Ib) (8).
- **Terapia cognitivo-conductual:** programación de actividades y técnicas cognitivas (detectar las creencias erróneas sobre los tratamientos farmacológicos para el dolor y la no necesidad de aguantar el dolor) (nivel de evidencia Ib y III) (8).

En las Asociaciones de Pacientes y Familiares (AECC, AMAC, ACEPAIN) el paciente también puede encontrar ayuda psicológica y aprender técnicas para controlar el dolor de manera no farmacológica (8).

Psicoterapia de grupo

Arndt *et al.*, consideran que los grupos de psicoterapia pueden causar una gran mejora en la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Otros autores señalan que tiene beneficios en forma de apoyo social y de auto - ayuda, disminuye la sensación de estigma, reduce el aislamiento social y facilita el aprendizaje de actitudes adaptativas y estrategias de afrontamiento ante el cáncer. Según Spiegel, esta son algunas de las ventajas de la psicoterapia grupal (1).

Los participantes en el grupo de apoyo, pueden tener la posibilidad de aumentar su red de apoyo social, reduciendo el aislamiento que pudieron sufrir ante el diagnóstico (1).

Según Spiegel el apoyo que se produce gracias a esta terapia, puede producir el principio de *helper - therapy*, en el cual el paciente mejora la autoestima ayudando a los demás, aprendiendo también actitudes adaptativas (1).

En definitiva, la psicoterapia grupal puede facilitar la expresión de sentimientos, como así muestra el testimonio de una paciente (1):

> *"me han hecho sentirme fuerte y no pobrecita. Verbalizar mi dolor ante los otros me liberó. Siempre había tapado mi angustia porque me han transmitido que eso es ser vulnerables o débiles. Es una imagen de mí que no había tenido antes en otro lugar".*

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)

A diferencia de lo propuesto por las terapias de "segunda generación", la ACT busca que el paciente tome distancia de sus eventos privados aversivos (pensamientos, emociones y sensaciones molestas), aceptándolos, para que así pueda reorientar su actuación a lo que considere importante en su vida, de acuerdo con sus valores (direcciones con significado) (2).

Estas actuaciones, que tienen en común promover el distanciamiento de los fenómenos mentales (defusión cognitiva) y suprimir los intentos de control emocional y cognitivo, han mostrado una eficacia superior a las terapias cognitivo - conductuales en el tratamiento de las alteraciones psicológicas de los pacientes de cáncer, así como en el mantenimiento de la mejoría en el largo plazo (2).

García Rasero y Tamayo Hernández, llevan a cabo una revisión sistemática sobre los estudios empíricos publicados en revistas de lengua inglesa y española, que permita establecer el estado actual de la ACT. La búsqueda de las publicaciones que reunieran los criterios de calidad científica y relevancia al objeto de estudio, arrojaron un total de ocho artículos (2).

El análisis estadístico de los resultados encontrados a través de la d de Cohen demuestra que la intervención desde la ACT en pacientes con cáncer conlleva una mejoría entre media y alta de la sintomatología ansiosa y depresiva, el distrés emocional, la calidad de vida, la flexibilidad psicológica y las expectativas ante la vida (2).

Técnicas de relajación

Hay varios tipos de técnicas de relajación y todas ellas producen un estado de calma, ayudando tanto a tratar episodios de aumento de dolor que provoca ansiedad o estrés emocional, al igual que a tratar la ansiedad que está asociada o provoca el aumento del dolor (4, 6).

Se ha demostrado su eficacia en situaciones de estrés, dolor, cefaleas tensionales y en la reducción de náuseas y vómitos provocados por la quimioterapia. Dichas técnicas también pueden ayudar a conciliar el sueño, a reducir la ansiedad y a tener más energía. Existen diferentes formas de practicar la relajación (8).

Normas generales para relajarse (consejos para el paciente) (8):

- Elegir un lugar tranquilo, con temperatura agradable y sin distracciones.
- Sentirse cómodo a la hora de realizar los ejercicios.
- Vestir ropa cómoda, si es holgada mejor.
- No cruzar las piernas ni brazos.

Iniciar los ejercicios de una de las siguientes maneras (8):

- Cerrando los ojos y pensar en algo agradable o fijando su mirada en un objeto.
- Concentrándose en su respiración, respire de forma lenta y rítmica.

Tipos de técnicas de relajación

Relajación muscular progresiva

La relajación muscular progresiva es una técnica que consta de una serie de ejercicios en los que el paciente contrae y relaja de forma alternante algunos grupos musculares de su cuerpo. El objetivo es relajar los músculos que están en tensión y causan dolor y notar la diferencia entre tensión y relajación. Se combina con la respiración, al apretar los músculos de forma controlada al inhalar y relajándolos al exhalar (8).

Visualización

Los ejercicios de visualización guiada, generan mentalmente un espacio seguro en el que el paciente se traslada, obteniendo el estado de calma que se busca (9).

Es una combinación entre la relajación física y la mental. Consiste en la elaboración de escenas mentales agradables. Es como soñar despierto. Se cierran los ojos y se crea imágenes en la mente que ayuden a relajarse, a sentir menos ansiedad y a dormir. Para lograr esto se tienen que usar todos los sentidos: la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. La visualización es una buena opción para las personas que deben quedarse en la cama o no pueden salir de la casa (8).

Un estudio llevado a cabo en Italia en 2019 demostró que la disminución del dolor en pacientes oncológicos terminales era mayor en aquellos que recibían sesiones de imágenes guiadas frente a los que recibían tratamiento convencional (9).

Musicoterapia

La musicoterapia es otro método basado en la distracción. Los sonidos musicales producen una relajación física y emocional que ayuda a reducir la ansiedad, el dolor y el miedo. La musicoterapia es parte integrante de las terapias multidisciplinarias que han demostrado indudables beneficios en el alivio del dolor, facilitación del sueño y mejora en la autoestima, entre otros (8).

Urretavizcaya Llamazares J., realizó una revisión crítica de la literatura de artículos obtenidos tras un proceso de búsqueda en diferentes bases de datos y mediante la búsqueda manual (10).

Finalmente, se realizó una lectura crítica de 18 artículos con el fin de examinar los efectos de la musicoterapia sobre la ansiedad y el dolor en pacientes adultos con un proceso oncológico, obteniendo como resultado que tanto en la ansiedad como en el dolor se ve un efecto positivo tras la aplicación de la musicoterapia en las diferentes etapas del proceso oncológico con diferencias relevantes entre el grupo control y grupo experimental de la mayoría de los artículos revisados (10).

Zavala Aquino EP, Rojas Maldonado Rl., Realizaron una revisión Sistemática observacional y retrospectiva, la búsqueda se ha restringido artículos con texto completo, y los artículos seleccionados se sometieron a una lectura crítica, utilizando el sistema GRADE para asignar la fuerza de recomendación (11).

Resultados: en la selección definitiva se eligieron 10 artículos, encontrando que el 40 % de las evidencias encontradas proceden de Estados Unidos, seguida del 20 % Brasil, 10 % Chille y por último 10 % proceden de Alemania. El total de artículos analizados afirma la eficacia de la musicoterapia para reducir el dolor y la ansiedad del paciente con cáncer (11).

Conclusiones: se evidenció en las investigaciones revisadas, que el uso de la musicoterapia es una alternativa prometedora, segura para disminuir el dolor y la ansiedad en el paciente con cáncer (11).

Distracción

En muchas ocasiones, principalmente durante el ingreso en un hospital, el paciente manifiesta sentimientos de aburrimiento y de bajo apoyo social, de soledad. Preguntarle al paciente acerca de cuáles son sus aficiones o hobbies (arte, música, lectura u otras aficiones), puede ayudar a focalizar la atención fuera del dolor, ayudando a tolerarlo (4).

La distracción consiste en realizar cualquier actividad que entretenga al paciente (escuchar la radio, hacer punto, trabajos manuales, pintar, leer, etc.) y pueda ayudar a no estar pensando continuamente en el dolor u otros problemas (8).

Hipnosis

A través de la hipnosis se logra un estado alterado de conciencia, ya que se focaliza la atención del paciente fuera de la sensación de dolor (6). No obstante, para que la técnica de hipnosis sea efectiva, requiere que el paciente posea una adecuada susceptibilidad hipnótica y tenga confianza en su terapeuta. Se utilizan diversos tipos de técnicas hipnóticas, como son (4):

- Ilusión de anestesia
- Sustitución sensorial
- Desplazamiento del dolor
- Disociación

Técnicas de meditación centrada en la compasión o autocompasión

Favorecen una actitud de apertura, aceptación y de amabilidad hacia uno mismo, que ayudan al control del dolor y al malestar emocional asociado a este (4).

Conclusiones

La intervención psicológica para el control del dolor debe ser empleada con carácter concomitante a los tratamientos analgésicos, y requiere, por supuesto, de la participación del paciente.

Estos tipos de intervenciones psicológicas son recomendables, fundamentalmente, en pacientes que presenten dolor leve o moderado, recomendado su uso en concomitancia con la administración del tratamiento analgésico.

Bibliografía

1. Garrido A. Intervención Psicológica en las Distintas Fases del Proceso Oncológico. Psychological Intervention in the Different Phases of the Oncological Process. junio de 2020. Recuperado a partir de: http://repositorio.ual.es/handle/10835/9709
2. García A, Tamayo J. Revisión sistemática sobre la eficacia de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) en el tratamiento psicológico de pacientes con cáncer. Psicooncología [Internet]. el 1 de enero de 2019 [citado el 21 de septiembre de 2021];16(1):101–25. Disponible en: https://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/view/63651
3. Díaz T, Carrasco J, Abreu M, Toirac R, Milian M, Dávalos C, *et al*. Atención integral al paciente oncológico con dolor. Rev Cuba Oncol [Internet]. el 2 de junio de 2021 [citado el 1 de septiembre de 2021];19(1). Disponible en: http://revoncologia.sld.cu/index.php/onc/article/view/90
4. Pérez C, Alonso A, Ramos A, Villegas F, Virizuela J. Guía para el abordaje interdisciplinar del dolor oncológico [Internet]. Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL); 2018. Disponible en: https://www.gado.es/descargar/Guia-GADO-Interactiva.pdf
5. Lavandera I. Interés del tratamiento no farmacológico en pacientes oncológicos. el 27 de abril de 2021 [citado el 1 de septiembre de 2021]; Disponible en: https://buleria.unileon.es/handle/10612/13189
6. León M, Santa J, Martínez S, Ibatá L. Recomendaciones basadas en evidencia para el manejo del dolor oncológico (revisión de la literatura). Rev Mex Anestesiol [Internet]. el 30 de enero de 2019 [citado el 1 de septiembre de 2021];42(1):45–55. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=84793
7. Maté J, Gil F, Ochoa C, Casella A, Trelis J, Calle C. Consenso sobre el estándar de atención psicooncológica, complejidad psicosocial y actividad asistencial en el Instituto Catalán de Oncología. el 1 de marzo de 2021 [citado el 21 de septiembre de 2021]; Disponible en: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/176962
8. Martínez M, Navarro L, Alcañiz A, Fernández P, Bravo P, Segura A. Valoración y manejo del dolor en el paciente oncológico y hematológico hospitalizado. Protocolo consensuado. 2018 [citado el 1 de septiembre de 2021]; Disponible en: https://www.chospab.es/enfermeria/RNAO/guias/protocolo-valoracion-manejo-dolor-paciente-oncologico-hematologico-hospitalizado.pdf
9. Rincón L. Técnicas complementarias para el manejo del dolor oncológico. Complementary techniques for the management of cancer pain [Internet]. el 30 de marzo de 2020 [citado el 1 de septiembre de 2021]; Disponible en: https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/20065
10. Urretavizcaya J. Conectar la música para desconectar: el manejo de la ansiedad y el dolor en un proceso oncológico. el 13 de septiembre de 2019 [citado el 21 de septiembre de 2021]; Disponible en: https://addi.ehu.es/handle/10810/35332
11. Zavala E, Rojas R. Eficacia de la musicoterapia para disminuir el dolor y la ansiedad en pacientes oncologicos. Univ Priv Norbert Wien [Internet]. el 6 de enero de 2019 [citado el 27 de septiembre de 2021]; Disponible en: http://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/123456789/2833